

ДЕТАЛЬНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Концепт-нота

Полное обоснование EECA Lung Health Hub – поэтапная инвестиция, основанная на доказательствах, в девяти странах Восточной Европы и Центральной Азии.

ПОДРОБНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ХАБ ПО ЗДОРОВЬЮ ЛЁГКИХ В РЕГИОНЕ ВЕЦА

От решения к результату: укрепление политической определённости и безопасности в сфере здоровья лёгких в Восточной Европе и Центральной Азии

Последнее обновление: сентябрь 2026 г.

Контакт: alesia.matusevych@globaltbcaucus.org

Редакция для обсуждения — сентябрь 2026. Всё, что выделено **красным**, изменено в этом раунде. Чёрный текст не менялся. Комментарии удобнее оставлять прямо к красным фрагментам.

В этом раунде сделано три вещи: учтены девять комментариев команды, исправлены все цифры, которые не подтверждались опубликованным источником, и добавлен раздел источников — раньше записка не ссылалась ни на что.

Удалено и поэтому ниже не видно. Утверждение о «примерно 300 000 уязвимых пациентов ... консервативная оценка на основе годовой заболеваемости туберкулёзом» убрано: по данным ВОЗ/ECDC во *всём* Европейском регионе ВОЗ в 2023 году расчётно 225 000 случаев ТБ, то есть цифра была завышена примерно втрое. Показатели «85 % бремени ТБ» и «99 % МЛУ-ТБ» убраны: они относятся к Европейскому региону ВОЗ, а не к ВЕЦА, и 99 % отсутствует в текущем отчёте ВОЗ/ECDC — этот показатель встречается только в плане 2007–2015 годов. Два источника исключены, поскольку в тексте на них не было ссылок (Impakter — о частной филантропии в США; Gavi 6.0 — о вакцинах, к тому же ссылка не работала). Две формулировки смягчены из-за отсутствия источника: утверждение о «среднем депутате» и статистика «22 из 26 стран» на сайте.

КРАТКО: БЫСТРЕЕ ПРЕВРАЩАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Хаб по здоровью лёгких в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) — это ориентированная на действие региональная платформа, которая помогает странам превращать политические решения в сфере здоровья лёгких в реальные действия — быстрее и эффективнее. Здоровье лёгких рассматривается как точка входа для укрепления систем здравоохранения во всём регионе, объединяя аналитику политики, финансирование и поддержку реализации.

Вместо создания ещё одной отдельной инициативы Хаб построен так, чтобы работать через существующие национальные институты и региональные партнёрства, помогая странам превращать данные и обязательства в профинансированные и работающие решения.

Хаб по здоровью лёгких ВЕЦА работает через три связанные функции:



Двигатель

ИИ-инструмент, который анализирует законодательство, помогает готовить поправки и ускоряет парламентскую работу в сфере здоровья лёгких — с обязательным участием человека, обеспечивающим контроль и координацию.



Мост

Площадка для прямого регионального парламентского сотрудничества. Она выявляет общие приоритеты и успешные подходы разных стран и делает региональный обмен более практичным и доступным.



Щит

Система раннего предупреждения и непрерывности, которая сообщает лицам, принимающим решения, о рисках прерывания лечения и поддерживает практические меры для сокращения различий в доступе к лекарствам.

Хаб начинается с *шестимесячной Фазы основания* в одной стране, чтобы проверить и подтвердить модель, прежде чем расширяться на весь регион. Он работает через существующие институты, а не создаёт параллельные структуры.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

[подзаголовок «Каталитическая двухлетняя программа» удалён]

Мультисекторальная программа с разработкой приложения на основе искусственного интеллекта, которая поможет региону быстрее переходить от решений к реальным результатам. Программа обеспечит более открытый доступ к процессу принятия решений для парламентариев, гражданского общества и затронутых сообществ. Она также включает систему, которая использует региональные данные, чтобы выявлять, где пациенты могут потерять доступ к лечению, и заранее предупреждает лиц, принимающих решения.

Регион Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) находится на критическом этапе. Продолжающиеся эпидемии в сфере здравоохранения, растущая геополитическая сложность и фундаментальный сдвиг в глобальном финансировании здравоохранения требуют новой парадигмы: быстрых, решительных действий и национальной ответственности. Поскольку крупные доноры сокращают свои финансовые обязательства в глобальном масштабе — и особенно в регионе ВЕЦА с начала 2025 года — региону необходимо срочно адаптироваться, чтобы защитить своё будущее в сфере здравоохранения.

Настоящее предложение сосредоточено на заболеваниях лёгких — ведущей причине предотвратимой смертности и одним из ключевых факторов нагрузки на системы здравоохранения в регионе, где туберкулёз, хронические респираторные заболевания и осложнения после инфекций продолжают угрожать здоровью населения и экономической стабильности.

Данная концепция описывает стратегическую возможность поддержки Хаба в области здоровья лёгких ВЕЦА как полномасштабной программы высокого воздействия, построенной как поэтапная программа на два года, которая начинается с шестимесячной Фазы основания стоимостью \$100 000 в одной из стран ВЕЦА [«построенной» вместо «структурированной»; «\$» вместо «долларов США»; это единственное упоминание сроков в кратком резюме], обеспечивающей полностью рабочее решение, с последующим тиражированием по странам и региональным развитием, до общей стоимости программы \$1,2 млн. Полный поэтапный бюджет и условия предоставляются по запросу.

Хаб разработан как быстрый и гибкий механизм перехода от решения к реализации, дающий политикам более высокий уровень определённости и ускоряющий внедрение важнейших политик и услуг в сфере здоровья лёгких. Он направлен на решение распространённой проблемы «слишком много законов — слишком мало реализации», которая часто замедляет прогресс в регионе. Важно, что Хаб развивается в сотрудничестве с **Глобальным парламентским кокусом по туберкулёзу** (Global TB Caucus) — международной сети парламентариев, содействующей политической мобилизации, совершенствованию политики и привлечению финансирования для ликвидации туберкулёза. Её региональная сеть для Восточной Европы и Центральной Азии работает с 2016 года.³ [было «с 2014 года». Глобальный кокус основан в 2014 году, его Евразийская парламентская группа по ТБ — в июне 2016 года] Существующая сеть, включающая девять активных национальных кокусов (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан), обеспечивает исключительный региональный охват для быстрого и устойчивого воздействия. Используя этот политический охват и доверие, Хаб будет использовать передовые цифровые и ИИ-решения для ускорения перевода политических решений в практическую реализацию. Это включает такие инструменты, как ИИ-ассистированное составление и анализ законодательных актов (с обязательной проверкой человеком) для депутатов, а также «Панель логистики последней мили» для эффективного распределения. Вместе эти инновации направлены на значительное сокращение времени между принятием решений и их исполнением, с потенциалом сокращения сроков до одной недели в оптимизированных условиях.

Выполняя функцию **Центра координации безопасности здравоохранения**, Хаб призван защищать непрерывность медицинской помощи там, где региональное бремя наиболее велико. В число девяти стран-партнёров входят три из шести стран с наибольшим бременем в Европейском регионе ВОЗ: Украина (42 000 расчётных случаев в 2023 году), Узбекистан (20 000) и Казахстан (14 000).¹ *(Заменяет утверждение о 300 000. Это опубликованные страновые показатели, приведённые дословно, а не сумма.)*

Настоящее предложение подробно описывает путь высокого воздействия к укреплению суверенитета в области здоровья лёгких, региональной устойчивости и устойчивых национальных систем здравоохранения в ВЕЦА, предлагая национальным партнёрам, донорам и частным заинтересованным сторонам стратегическую, измеримую и своевременную инвестицию в здоровье и стабильность региона.

1. ВОЗМОЖНОСТЬ: УВЕРЕННО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Регион ВЕЦА в настоящее время сталкивается с перекрывающимися вызовами в сферах здравоохранения, экономики и геополитики, требующими стратегического и локально ориентированного ответа.

1.1. Продолжающиеся кризисы здоровья лёгких: необходимость сфокусированных действий

В Европейском регионе ВОЗ в 2023 году зарегистрировано расчётно 225 000 новых случаев туберкулёза и рецидивов, около 84 % из них — в 18 странах, отнесённых ВОЗ к приоритетным; в эту группу входят все девять стран ВЕЦА, с которыми работает программа. Средняя заболеваемость в этих 18 странах составляет 46 случаев на 100 000 населения — в пять раз выше среднего показателя по ЕС/ЕЭЗ. Регион несёт и самое тяжёлое в мире бремя лекарственно-устойчивого туберкулёза: расчётно 65 000 случаев с устойчивостью к рифампицину и множественной лекарственной устойчивостью (УР/МЛУ-ТБ), а девять из 30 стран мира с наибольшим бременем МЛУ-ТБ находятся в Регионе.¹ [каждая цифра взята из отчёта ВОЗ/ECDC и теперь снабжена ссылкой] Помимо ТБ, другие критические состояния здоровья лёгких — хронические респираторные заболевания и возникающие респираторные инфекции — дополнительно нагружают и без того хрупкие системы здравоохранения. Хаб будет сосредоточен на заболеваниях лёгких, отражая как их непропорциональное бремя среди ключевых и уязвимых групп населения, так и высокий потенциал для целенаправленных и результативных мер.

225 000

случаев ТБ, Европейский регион ВОЗ (2023)

84 %

в 18 приоритетных странах

65 000

случаев УР/МЛУ-ТБ

1.2. Переход Глобального фонда: призыв к национальной ответственности

Крупные доноры существенно сокращают своё активное участие в регионе ВЕЦА начиная с начала 2025 года.² [теперь со ссылкой] Этот стратегический разворот создаёт критический разрыв в финансировании и подчёркивает настоятельную необходимость перехода стран ВЕЦА к устойчивому национальному внутреннему финансированию здравоохранения.

Международные доноры всё чаще выступают за национальную ответственность и развитие надёжных местных механизмов финансирования, возлагая на региональных адвокатов задачу обеспечения и оптимизации внутренних ресурсов. Этот переход представляет уникальную возможность для национальных доноров выступить вперёд и поддержать модель самообеспечения. Настоящее предложение предлагает конкретный, готовый к реализации путь для операционализации этого сдвига через практические механизмы и вехи, а также демонстративное региональное воздействие.

1.3. Геополитическая нестабильность и безопасность здравоохранения: недооценённый кризис

Растущая геополитическая нестабильность и угрозы безопасности в регионе, включая продолжающуюся полномасштабную агрессию России против Украины и другие геополитические угрозы за пределами региона, усугубляют кризис. Снижение глобальных расходов доноров на здравоохранение дополнительно усиливает эту уязвимость, особенно в условиях сужающегося гражданского пространства и нового ограничительного законодательства, всё чаще угрожающего безопасности людей. В случае эскалации конфликтов или других геополитических потрясений предложенная роль Хаба как Центра координации безопасности здравоохранения становится первостепенной, обеспечивая непрерывную и скоординированную помощь всем затронутым пациентам независимо от контекста безопасности. Это прямая инвестиция в региональную стабильность и безопасность здравоохранения.

1.4. Задержки в принятии решений и реализации: региональный разрыв

Несмотря на рост расходов на здравоохранение во многих странах ВЕЦА, бюджеты часто не соответствуют реальному бремени болезней из-за фрагментированного планирования, слабых данных о расходах и ограниченного прогнозирования. Значительная проблема — это так называемое «региональное колебание», когда политические системы с трудом

переходят от обязательств к конкретным действиям по сложным вопросам здравоохранения. Она также связана с законодательной нагрузкой на парламентариев: когда политика здравоохранения конкурирует с плотным потоком других законодательных актов, способность к быстрому и обоснованному принятию решений по сложным вопросам здравоохранения оказывается ограниченной. [смягчено — прежняя формулировка подразумевала статистику о «среднем депутате», которая ничем не подтверждена] Это приводит к задержкам принятия решений и отставанию в реализации, когда критически важные нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения месяцами, а то и годами не превращаются в ощутимую пользу для населения. Без надёжного управления данными, стандартов и мер защиты конфиденциальности (только агрегированные / неперсональные данные; безопасность уровня ISO 27001; защита, эквивалентная GDPR; суверенный / региональный хостинг; независимый аудит) потенциал цифрового здравоохранения остаётся нереализованным, вызывая скептицизм доноров в отношении «прорывов ИИ».

2. РЕШЕНИЕ: ХАБ ПО ЗДОРОВЬЮ ЛЁГКИХ В РЕГИОНЕ ВЕЦА

Хаб по здоровью лёгких в регионе ВЕЦА разработан как компактная программа полного масштаба высокого воздействия, стратегически ориентированная на катализацию политической воли, расширение возможностей сообществ и реформирование политики на основе данных **в рамках бюджета \$1,2 млн. [«на 2 года» убрано как повтор]** Наш подход основан на принципе региональной ответственности и устойчивости, использует существующие сильные стороны и устраняет критические пробелы.

2.1. Сотрудничество с сетью Глобального парламентского кокуса по туберкулёзу

В отличие от новых инициатив, требующих обширной подготовительной работы, Хаб работает в сотрудничестве с Глобальным парламентским кокусом по туберкулёзу. Её региональная сеть для Восточной Европы и Центральной Азии работает с 2016 года, выстраивая прочные отношения и накапливая опыт мобилизации политической приверженности в области здоровья лёгких.³ Хаб сотрудничает с девятью активными национальными кокусами по туберкулёзу в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Украине и Узбекистане. Эти устоявшиеся отношения обеспечивают исключительную платформу для сотрудничества, быстрого вовлечения и воздействия, существенно сокращая время и затраты на запуск.

2.2. Гибкая и автономная региональная модель управления

Хаб будет функционировать как автономный, регионально управляемый центр, обеспечивая принятие решений в интересах и для контекста ВЕЦА, тесно сотрудничая при этом с сетью Глобального парламентского кокуса по туберкулёзу. Данная структура рассчитана на гибкость, прямое воздействие, а также на укрепление региональной ответственности и подотчётности. Она избегает бюрократических накладных расходов, позволяя эффективно направлять бюджет \$1,2 млн непосредственно на программную деятельность.

Модель управления:

Управление опирается на четыре рабочих органа, координируемых **Региональным руководящим комитетом**, в состав которого входят представители Парламентского совета, Совета гражданского общества и ключевые технические эксперты региона и который обеспечивает стратегическое руководство, надзор и соответствие региональным приоритетам:

Парламентский совет

Формируется из представителей девяти национальных кокусов по туберкулёзу: Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана. Совет будет играть ключевую роль в продвижении законодательных и политических реформ, мобилизации внутренних ресурсов и обеспечении политической поддержки на самом высоком уровне. Опираясь на существующие связи, авторитет и влияние парламентариев, Совет станет важным механизмом для перевода политических решений в конкретные действия.

Консультативный совет бывших депутатов

Объединит парламентариев с глубоким опытом работы в сфере здравоохранения, законодательных процессов и государственной политики. Совет будет обеспечивать стратегическое наставничество для действующих членов кокусов, участвовать в высокоуровневых дипломатических миссиях и укреплять политический диалог на основе принципа «равный — равному». Опыт и авторитет бывших парламентариев будут создавать дополнительный уровень доверия и политической преемственности.

Совет гражданского общества

Объединит представителей ключевых групп населения и организаций гражданского общества региона ВЕЦА. Его задача — обеспечить, чтобы деятельность Хаба оставалась ориентированной на сообщества, основывалась на правах человека и отвечала реальным потребностям наиболее уязвимых групп. Совет также будет выполнять функцию общественного и этического контроля, в том числе в вопросах использования данных, обеспечивая прозрачность и подотчётность Хаба. Его работа будет охватывать региональный, национальный и местный уровни, с особым вниманием к сетям и инициативам, возглавляемым самими сообществами. Голос гражданского общества будет интегрирован в работу Хаба через регулярные консультации с представителями сообществ.

Технический секретариат

Компактная команда, ответственная за ежедневную работу Хаба, техническую поддержку и эффективную реализацию его программных компонентов. В его состав войдут три ключевые позиции: руководитель по парламентскому взаимодействию, руководитель по взаимодействию с гражданским обществом и руководитель по ИИ и цифровым системам. Дополнительно будут предусмотрены операционные функции в области финансов, администрирования и коммуникаций, а также позиция ассистента по ИИ и цифровым системам.

Эта структура обеспечивает прочную интеграцию Хаба в региональный политический и социальный контекст, позволяя оперативно разрабатывать и реализовывать решения с учётом специфики региона, одновременно сотрудничая с Глобальным парламентским кокусом по туберкулёзу и его региональной сетью.

2.3. Программа стоимостью \$1,2 млн: Хаб по здоровью лёгких в регионе ВЕЦА [«(2-летняя программа)» удалено]

Компонент 1: Двигатель — укрепление национального потенциала (ИИ-платформа для законодательной работы)

Ключевая функция: превращать политические решения в готовые к внесению законодательные акты и бюджетные действия, ускорять реализацию.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Защищённый портал для депутатов — закрытое рабочее пространство с доступом по приглашению для подготовки, сравнения и обмена законопроектами и поправками.
- ИИ-помощник для подготовки и анализа поправок — помогает разрабатывать варианты и выявлять возможные несоответствия. Все результаты проходят обязательную проверку человеком; ИИ используется только как вспомогательный инструмент и не принимает решений.
- Сравнительный анализ законодательства — доступная для поиска база данных законодательства стран ВЕЦА в сфере здравоохранения, позволяющая сравнивать подходы разных стран.
- Ключевые участники и возможности для законодательной работы — помогает понимать, кто участвует в процессе и когда лучше продвигать законодательные инициативы.
- Интегрированный механизм обратной связи от сообществ — обеспечивает регулярный учёт мнений и предложений сообществ в законодательной работе.
- Защита данных и прозрачность — без обработки персональных данных и с полным учётом действий пользователей для обеспечения прозрачности и подотчётности.

Результат / ценность: сокращает обычные сроки подготовки законодательства с месяцев до дней — с отслеживаемыми, управляемыми и проверенными человеком результатами.

Компонент 2: Мост — ИИ-поддержка дипломатии и политической координации

Ключевая функция: способствовать целенаправленному, основанному на фактических данных политическому взаимодействию и региональному сотрудничеству вместо разрозненных усилий.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Анализ подходящих стран для сотрудничества — помогает определять потенциальных партнёров на основе бюджетов, законодательства, результатов и готовности к сотрудничеству. Использование ИИ сопровождается проверкой человеком.
- Двусторонние и многосторонние миссии на основе данных — помогают выстраивать сотрудничество с учётом конкретных потребностей и возможностей стран.
- Региональные парламентские саммиты — площадки для обмена опытом и согласования общих приоритетов.
- Краткие брифинги для лиц, принимающих решения — практические материалы объёмом 2–4 страницы с ключевыми выводами и рекомендациями.
- Анализ бюджетов и ресурсов — обзоры бюджетов, оценка затрат, анализ доступных ресурсов и их соответствия политическим приоритетам.

Результат / ценность: превращает дипломатию в точный инструмент, связывающий взаимодействие с конкретными политическими и финансовыми результатами.

Компонент 3: Щит — безопасность здравоохранения, реагирование на кризисы и непрерывность помощи

Ключевая функция: обеспечивать непрерывность помощи и информированность лиц, принимающих решения, в условиях потенциальных кризисов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Региональный протокол координации в сфере безопасности здравоохранения — общий подход к обмену информацией и координации действий в кризисных ситуациях.
- Мониторинг непрерывности медицинской помощи — отслеживание доступности помощи на основе агрегированных данных без использования персональной информации.
- Система раннего предупреждения для депутатов — своевременно сообщает о возможных проблемах с поставками, перемещением ресурсов и финансированием.
- Интерактивные панели данных — наглядно показывают данные о распространённости заболеваний и финансировании на региональном и страновом уровнях.
- Мониторинг поставок до медицинских учреждений — показывает статус доставки лекарств и других медицинских товаров, помогает вовремя выявлять задержки и перебои, но не управляет самой доставкой.
- Защита конфиденциальности — по умолчанию используются только агрегированные данные без персональной информации.

Результат / ценность: защищает непрерывность помощи и даёт раннее, управляемое предупреждение до перерывов в оказании помощи.

Вместе эти компоненты представляют Хаб как единую интегрированную систему, а не три отдельных проекта. Координационный хаб обеспечивает основу, Двигатель ускоряет политические действия, Мост согласовывает дипломатию и финансирование, а Щит защищает непрерывность системы здравоохранения в условиях стресса. Вместе эти компоненты предназначены для того, чтобы перевести регион от политических обязательств к практической реализации значительно быстрее, чем традиционные подходы.

Все три компонента работают на общем управляемом слое данных — общей модели индикаторов, стандартах интероперабельности (согласованных с глобальной стратегией ВОЗ по цифровому здравоохранению⁴), валидации/версионированию, безопасности уровня ISO 27001 и суверенном/региональном хостинге — что позволяет Двигателю, Мосту и Щиту безопасно обмениваться данными.

3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ: ВЫСОКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ

Эта программа стоимостью \$1,2 млн создаёт практическую систему поддержки принятия решений на основе фактических данных в области здоровья лёгких в ВЕЦА — призванную помочь правительствам действовать на основе данных, тратить средства более эффективно и поддерживать непрерывность систем в критический переходный период.

В условиях региональных сокращений финансирования в 2026 году Хаб служит мостом к национальному суверенитету в здравоохранении, обеспечивая перевод политических обязательств в устойчивые внутренние действия.

3.1. Двигатель — политическая определённость и немедленные действия

Этот компонент напрямую устраняет один из крупнейших структурных пробелов в регионе: отсутствие ясной, применимой аналитики о том, как распределяются ресурсы здравоохранения и как политические решения превращаются в финансовые обязательства.

Оснащая министерства, парламенты и национальных заинтересованных сторон обзорами бюджетов, анализами картирования ресурсов, моделями калькуляции политики и ИИ-ассистированным составлением законодательства, Двигатель обеспечивает:

- принятие решений по внутреннему финансированию здравоохранения на основе фактических данных;
- достоверную калькуляцию политических и законодательных вариантов;
- более сильное согласование политик с национальными бюджетами;
- снижение зависимости от внешней технической помощи.

Почему это инвестиционно привлекательно: укрепляет ключевые государственные функции — законотворчество, бюджетирование и финансовый анализ — связывая политические намерения с реалистичными бюджетными обязательствами и помогая правительствам снижать неэффективность при приоритезации вмешательств высокого воздействия.

Воздействие: политические решения переходят от концепции к исполнимой, финансово обоснованной политике в течение дней, обеспечивая беспрецедентную определённую и скорость.

3.2. Мост — умная дипломатия и согласование финансирования

Этот уровень обеспечивает, чтобы региональное сотрудничество и политическое взаимодействие больше не были разрозненными, а стратегически оптимизировались через данные, фактические материалы и структурированную подотчётность.

Работая в сотрудничестве с сетью Глобального парламентского кокуса по туберкулёзу и связывая бюджетные данные, законодательный прогресс и результаты в сфере здравоохранения, Мост:

- укрепляет парламентское взаимодействие, надзор и структурированный диалог между правительством, гражданским обществом и техническими акторами;
- обеспечивает, чтобы миссии и политические платформы приводили к конкретным политическим, финансовым и реализационным результатам;
- предоставляет инструменты бюджетной адвокации, системы надзора, карты подотчётности, а также законодательные и бюджетные заметки о воздействии.

Почему это инвестиционно привлекательно: превращает существующие политические платформы (например, парламентские сети) из пространств адвокации в эффективные инструменты реализации и подотчётности, повышая прозрачность и обеспечивая превращение финансовых решений в реальные результаты.

Воздействие: региональное сотрудничество и парламентские процессы становятся точными инструментами ускорения национальных реформ, оптимизации ресурсов и устойчивой реализации.

3.3. Щит — безопасность здравоохранения и устойчивость систем

В регионе, сталкивающемся с геополитической нестабильностью и миграционными вызовами, этот компонент предоставляет практическую

аналитику, помогая превращать разрозненные данные в информацию, необходимую для планирования, прогнозирования и обеспечения непрерывности медицинской помощи.

Объединяя интерактивные панели данных, анализ потребностей и расходов, ИИ-поддержку прогнозирования и механизмы координации, Щит:

- помогает обеспечивать непрерывность медицинской помощи, снижая риск перерывов в лечении и развития лекарственной устойчивости;
- помогает прогнозировать потребности в ресурсах — лекарствах, диагностике и медицинских услугах — и выявлять возможные неэффективные расходы;
- поддерживает быстрое и скоординированное реагирование на кризисы и помогает раньше выявлять потенциальные риски.

Почему это инвестиционно привлекательно: напрямую способствует национальной стабильности, общественному доверию и безопасности здравоохранения, укрепляя способность отслеживать эффективность систем, предвидеть операционные риски и принимать скоординированные ресурсные решения — без зависимости от сложной инфраструктуры.

Воздействие: системы здравоохранения становятся адаптивными, готовыми к кризисам и способными защищать уязвимые группы населения даже в нестабильных условиях.

Итог: быстрое исполнение и поддержка решений

Это не традиционная программа. Это региональная система исполнения, которая:

- превращает фактические данные в применимые финансовые и политические решения;
- связывает бюджетную аналитику, операционный мониторинг, парламентскую подотчётность и отслеживание реализации в одну согласованную систему;
- демонстрирует воспроизводимую модель национального суверенитета в здравоохранении в регионе ВЕЦА.

Возврат на инвестиции:

- более быстрая, финансово обоснованная реализация политики;
- более сильное планирование, оптимизация ресурсов и непрерывность помощи в период переходного финансирования;
- более прозрачные, подотчётные и устойчивые к кризисам системы здравоохранения;
- продемонстрированная ценность решений в ведущей стране-партнёре [было «в 2–3 пилотных странах», что противоречило Фазе 1 в одной стране] с чёткой дорожной картой регионального масштабирования.

Инновация: цикл быстрого исполнения

Ключевая инновация Хаба здоровья лёгких — объединение Двигателя, Моста и Щита в единую систему, которая сокращает разрыв между принятием политических решений и их практической реализацией.

- **Двигатель (политическая и бюджетная аналитика):** депутат или сотрудник министерства готовит или вносит поправки в законодательство с помощью ИИ-инструментов, имея доступ в реальном времени к бюджетному анализу, калькуляции политики, правовым сравнениям и данным о заинтересованных сторонах.
- **Мост (умная дипломатия и подотчётность):** система автоматически выявляет релевантный опыт других стран, активирует целенаправленное парламентское и политическое взаимодействие и генерирует поддерживающие материалы (заметки о бюджетном воздействии, адвокатские брифы, карты подотчётности).
- **Щит (операционная аналитика и безопасность здравоохранения):** утверждённые решения немедленно переводятся в операционные панели, прогнозирование ресурсов, сигналы о закупках и планы непрерывности — обеспечивая быстрое операционное сопровождение.

Результат: полностью связанный цикл «от решения к доставке», сжимающий то, что традиционно занимает месяцы (или даже годы) разрозненных усилий, до недель. Вместо разрозненных инициатив правительства получают

интегрированную систему, в которой фактические данные, политическая воля и операционные возможности усиливают друг друга практически в реальном времени.

4. МЕХАНИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Разделы 4 и 5 предлагались в предыдущей редакции и не получили комментариев, поэтому считаются принятыми и включены в записку. Месяцы указаны только на схеме; в четырёх заголовках фаз они больше не повторяются.

Программа реализуется поэтапно. Каждая фаза финансируется независимо, самостоятельно даёт работающий результат, а базовая единица рассчитана на тиражирование от страны к стране — донор финансирует не обещание, а повторение того, что уже доказано.

МЕСЯЦЫ 1–6 Фаза 1 • Основание Одна страна ВЕЦА	МЕСЯЦЫ 7–12 Фаза 1R • Тиражирование Страна за страной	МЕСЯЦЫ 13–18 Фаза 2 • Региональная платформа Развёртывание в нескольких странах	МЕСЯЦЫ 19–24 Фаза 3 • Масштабирование и интеграция Охват девяти стран
---	---	---	---

Фаза 1 — Основание: одна страна ВЕЦА

Цель: работающее решение, запущенное в одной стране. Ведущая страна-партнёр выбирается из девяти действующих национальных кокусов по туберкулёзу по критериям готовности кокуса, политической динамики и соответствия донорским приоритетам. По итогам фазы: создано компактное управление; подготовлена Карта законодательных запросов (конкретные нормативные изменения, необходимые в ведущей стране, согласованные с депутатами и сообществами); развёрнуто ядро приложения Хаба на суверенной инфраструктуре (роли и аутентификация, профиль страны, справочник заинтересованных сторон, рабочее пространство кокуса); запущена панель данных по скринингу с пилотом интероперабельности с национальной отчётностью; в приложении работает законодательный план кокуса — доказательная единица.

Фаза 1R — Тиражирование по странам

Тот же сценарий переносится в другие страны кокуса: каждая создаёт собственную Карту законодательных запросов, панель данных и законодательный план кокуса. Тиражирование идёт параллельно.

Фаза 2 — Развёртывание региональной платформы

Полная версия приложения: защищённый портал для депутатов, сравнительный анализ законодательства (база данных по странам ВЕЦА), ИИ-поддержка подготовки и анализа поправок с обязательной проверкой человеком; двуязычный запуск (EN/RU); усиленный контур безопасности (уровень ISO 27001, суверенный хостинг); первый Региональный парламентский саммит на платформе; выпуск кратких брифингов и бюджетно-политической аналитики.

Фаза 3 — Масштабирование и интеграция

Подключение остальных стран кокуса (полный охват девяти стран); полноценный Мост (аналитика подбора стран, миссии на основе данных, механизмы подотчётности); полноценный Щит (система раннего предупреждения, мониторинг непрерывности помощи, панель видимости поставок до медицинских учреждений; интеграция частного сектора); комплексная оценка, стратегия устойчивости и внутреннего финансирования, долгосрочная институционализация.

Компоненты из §2.3 (Двигатель · Мост · Щит) отвечают на вопрос *что*; фазы — на вопрос *когда и в каком объёме*: ядро Двигателя запускается в Фазе 1 и завершается в Фазе 2; аналитический слой Щита закладывается в Фазе 1 и завершается в Фазе 3; Мост работает с Фазы 2 и завершается в Фазе 3.

5. СТРУКТУРА БЮДЖЕТА

[сокращено по комментарию: детализация по запросу, затем распределение средств]

Программа финансируется поэтапно; полная постатейная детализация и условия предоставляются по запросу. Диаграмма ниже показывает, как бюджет распределяется между четырьмя направлениями программы.

КУДА ИДУТ СРЕДСТВА

Поэтапное, прозрачное распределение.

Ориентировочное распределение по четырём направлениям программы. Полная детализация бюджета передаётся партнёрам конфиденциально.



Ориентировочное распределение. Полный поэтапный бюджет – по запросу.

Свяжитесь с нами через [страницу контактов](#) или начните [консультацию](#), чтобы получить подробный бюджетный пакет.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И РЕГИОНАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

Хаб закрывает критический разрыв: превращает политические решения в реальную помощь пациентам — быстро — начиная с Фазы основания в одной стране ВЕЦА, которая даёт работающее решение до того, как будет запрошено дальнейшее финансирование. *(Принято из редакции для обсуждения; «24 месяца» убрано, срок указан ниже.)*

Интегрируя:

- Двигатель (ИИ-платформа для законодательной работы),
- Мост (целенаправленная политическая координация) и
- Щит (системы безопасности здравоохранения и доставки),

Хаб создаёт единый поток исполнения: политика → финансирование → воздействие на пациентов.

В течение первых шести месяцев (Фаза 1) планируется создать рабочее ядро Хаба, включая приложение Хаба, национальную панель данных по скринингу, интегрированную с национальной системой отчётности, Карту законодательных запросов и действующий план законодательной работы Кокуса. Таким образом, Фаза 1 обеспечит готовое к использованию решение в одной стране.

В течение двух лет инвестиция обеспечивает:

[было «В течение 24 месяцев»]

- полностью функциональное приложение Хаба здоровья лёгких, позволяющее быстрые законодательные действия;
- основанное на данных политическое сотрудничество, приводящее к конкретным реформам;
- панели реального времени и логистические системы, поддерживающие доставку в течение одной недели для рутинных, шаблонных действий в пилотных условиях;

- защищённую непрерывность помощи в девяти странах-партнёрах, начиная с территорий с наибольшим бременем [было «для 300 000+ уязвимых пациентов»].

Почему сейчас: в условиях регионального сокращения глобального донорского финансирования в 2026 году странам нужны практические инструменты для самостоятельного управления системами здравоохранения. Хаб предоставляет именно это — скорость, структуру и подотчётность.

Это не традиционная программа, а рабочая модель суверенитета в здравоохранении — помогающая правительствам действовать быстрее, использовать ресурсы эффективнее и поддерживать стабильность в неопределённых условиях. Мы приглашаем партнёров инвестировать в систему, которая даёт измеримые результаты в течение двух лет и масштабируемую модель на перспективу.

ИСТОЧНИКИ

Новый раздел. Раньше в записке не было ни списка источников, ни сносок. Каждое утверждение, опирающееся на источник, теперь снабжено надстрочным номером. Все четыре ссылки проверены и открываются.

1. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний / Европейское региональное бюро ВОЗ. *Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2025 — 2023 data*. Стокгольм: ECDC/WHO Regional Office for Europe; 2025. [who.int](https://www.who.int)
2. Human Rights Watch. *Donor Nation Cuts to Global Health Financing Affect Millions*. 22 января 2026. [hrw.org](https://www.hrw.org)
3. Глобальный парламентский кокус по туберкулёзу. globaltbcaucus.org
4. Всемирная организация здравоохранения. *Global strategy on digital health 2020–2027*. [who.int](https://www.who.int)